

PAC PEDIÁTRICA — IDADE DEFINE A CONDUTA

ETIOLOGIA POR FAIXA ETÁRIA

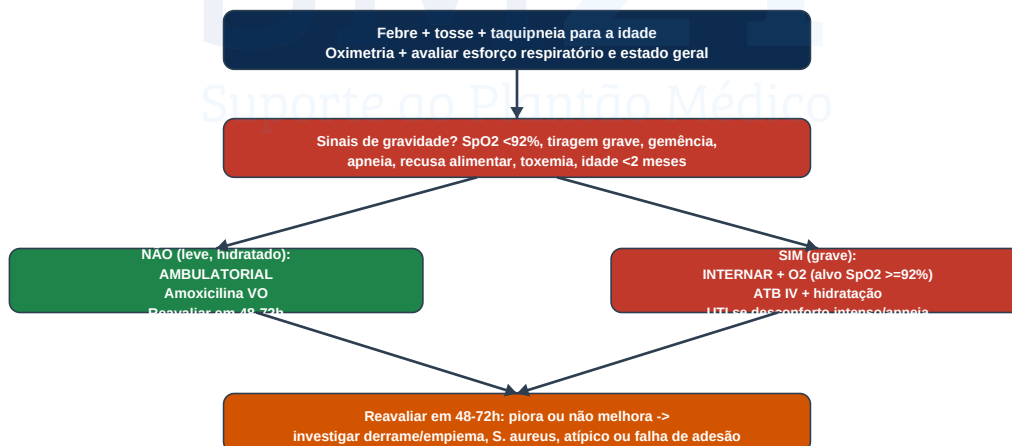
Faixa etária	Agentes mais prováveis	Observação
Neonato (<1 mês)	Streptococcus do grupo B (GBS), E. coli e Gram-negativos, Listeria	Sempre internar; cobertura de sepse neonatal
1-3 meses	Febril: vírus, pneumococo. Afebril: Chlamydia trachomatis, Bordetella, vírus	Pneumonia afebril do lactente: tosse + taquipneia sem febre
4 meses a 5 anos	VÍRUS (VSR, influenza, adenovírus, rinovírus) — mais comum. Bacteriana: S. pneumoniae	Vírus predomina nos menores; pneumococo lidera entre as bactérias
Maior de 5 anos	S. pneumoniae + ATÍPICOS (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae)	Mycoplasma comum no escolar/adolescente
Qualquer idade (grave)	S. aureus (inclui MRSA), pneumococo invasivo	Suspeitar de S. aureus em pneumonia necrosante/derrame

DIAGNÓSTICO — TAQUIPNEIA (OMS) E SINAIS

Idade	Taquipneia (irpm)	Sinais de pneumonia
< 2 meses	≥ 60	Taquipneia é o sinal mais sensível; contar FR em 1 min com a criança calma
2 a 12 meses	≥ 50	Tiragem subcostal, batimento de asa nasal, gemência, estertores
1 a 5 anos	≥ 40	Febre + tosse + taquipneia; ausculta pode ser normal nos menores
> 5 anos	$\geq 20-30$	Quadro mais típico: febre, tosse, dor torácica, estertores localizados
Diagnóstico	Clínico	Raio-X NÃO é rotina no ambulatório; reservar para dúvida, gravidade ou complicação
Hipoxemia	SpO ₂ < 92%	Oximetria em todo paciente com suspeita; critério de gravidade/internação

FLUXO — ONDE TRATAR A PAC PEDIÁTRICA

PAC CRIANÇA — GRAVIDADE DEFINE O LOCAL



CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO E SINAIS DE ALARME

QUANDO NÃO DAR ALTA

- Hipoxemia: SpO₂ < 92% em ar ambiente (critério objetivo mais importante)
- Desconforto respiratório grave: tiragem intercostal/subcostal acentuada, gemência, batimento de asa nasal
- Idade < 2 meses (sempre internar) ou apneia / episódios de cianose
- Incapacidade de aceitar líquidos/alimentos, vômitos, sinais de desidratação
- Toxemia, alteração do sensorio ou aspecto séptico
- Comorbidade (cardiopatia, pneumopatia crônica, imunodeficiência, desnutrição grave, anemia falciforme)
- Falha do tratamento ambulatorial em 48-72h ou suspeita de complicação (derrame, necrose)
- Família sem condições de observar/retornar ou difícil acesso ao serviço

MODELO DE PRESCRIÇÃO — ANTIBIÓTICO POR CENÁRIO

Rx DOSES PEDIÁTRICAS (RESPEITAR DOSE MÁXIMA DO ADULTO)

AMBULATORIAL (>2 meses, hígido, vacinado): Amoxicilina 50 mg/kg/dia VO 8/8h ou 12/12h por 5-7 dias (até 90 mg/kg/dia em área de pneumococo resistente)

ESCOLAR/ADOLESCENTE com suspeita de ATÍPICO: Azitromicina 10 mg/kg no D1 (máx 500 mg) e 5 mg/kg/dia do D2 ao D5 (máx 250 mg) — cobre Mycoplasma/Chlamydia

INTERNADO (forma típica): Penicilina cristalina 200.000 UI/kg/dia IV 6/6h OU Ampicilina 150-200 mg/kg/dia IV 6/6h

INTERNADO grave / não vacinado / falha da VO: Ceftriaxona 50-100 mg/kg/dia IV (máx 2-4 g/dia)

SUSPEITA de S. aureus (necrosante, derrame, lactente toxemiado): Oxacilina 150-200 mg/kg/dia IV 6/6h; Vancomicina 40-60 mg/kg/dia se MRSA/grave

< 2 meses: internar — Ampicilina + Gentamicina (ou Cefotaxima); cobrir flora neonatal

INFLUENZA confirmada/suspeita: associar Oseltamivir conforme peso por 5 dias

Suporte: O₂ para SpO₂ >= 92%, hidratação, antitérmico; NÃO usar antitussígeno

VIRAL x BACTERIANA E COMPLICAÇÕES

Pistas: Viral x Bacteriana

- Viral: lactente, início gradual, coriza/sibilos, febre baixa, infiltrado intersticial bilateral
- Bacteriana típica: início agudo, febre alta, toxemia, condensação lobar, leucocitose com desvio
- Atípica (Mycoplasma): escolar, tosse arrastada, sintomas extrapulmonares, RX pior que a ausculta
- Procalcitonina/PCR ajudam mas NÃO definem isoladamente
- Sibilância difusa favorece etiologia viral (evitar ATB se quadro típico de bronquiolite)

Complicações

- Derrame parapneumônico / empiema: pesquisar se febre persistente > 48-72h
- USG de tórax: melhor para detectar e guiar punção do derrame
- Empiema: drenagem torácica; considerar fibrinolítico intrapleural ou VATS
- Pneumonia necrosante e pneumatocele: associadas a S. aureus e pneumococo
- Abscesso pulmonar e fístula broncopulmonar: formas graves, internação prolongada

REAVALIAÇÃO, ALTA E PREVENÇÃO

FECHAMENTO DO CASO

- ☐ Reavaliar em 48-72h: afebril, menos taquipneico e aceitando dieta = boa resposta
- ☐ Sem melhora: rever adesão/dose, pensar em derrame, *S. aureus*, atípico ou diagnóstico alternativo
- ☐ Alta hospitalar: SpO2 estável em ar ambiente, aceitando VO, sem desconforto, família orientada
- ☐ Duração: 5-7 dias na maioria; 7-10 dias (ou mais) em formas graves/complicadas
- ☐ Trocar IV por VO quando afebril, estável e tolerando dieta (terapia sequencial)
- ☐ Prevenção: vacinas (pneumocócica conjugada, Hib, coqueluche, influenza anual), aleitamento materno e evitar tabagismo passivo



FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

SBP / Adaptada

Lactente de 18 meses, previamente hígido e vacinado, com febre, tosse e FR de 46 irpm, SpO2 97%, aceitando líquidos e sem tiragem. Qual a conduta?

- A) Internar e iniciar ceftriaxona IV
- B) Tratamento ambulatorial com amoxicilina VO e reavaliação em 48-72h
- C) Azitromicina VO como primeira escolha
- D) Apenas sintomáticos, pois é seguramente viral
- E) Oseltamivir isolado por 5 dias

QUESTÃO 2

FMUSP / Adaptada

Qual é o agente etiológico MAIS COMUM de pneumonia em crianças entre 4 meses e 5 anos?

- A) Streptococcus pneumoniae
- B) Mycoplasma pneumoniae
- C) Vírus (VSR, influenza, adenovírus, rinovírus)
- D) Staphylococcus aureus
- E) Haemophilus influenzae tipo b

QUESTÃO 3

SBP / Adaptada

Escolar de 8 anos com tosse arrastada de 2 semanas, febre baixa, ausculta com poucos achados e RX com infiltrado intersticial. Qual o agente provável e o antibiótico de escolha?

- A) S. pneumoniae — amoxicilina
- B) Mycoplasma pneumoniae — macrolídeo (azitromicina)
- C) S. aureus — oxacilina
- D) Vírus — apenas sintomáticos
- E) Pseudomonas — ceftazidima

QUESTÃO 4

AMRIGS / Adaptada

Qual é o critério OBJETIVO mais importante de gravidade que indica internação na PAC pediátrica?

- A) Febre acima de 39 graus
- B) Leucocitose acima de 15.000
- C) SpO2 < 92% em ar ambiente
- D) Presença de tosse produtiva
- E) Infiltrado lobar no raio-X

QUESTÃO 5

SES-SP / Adaptada

Criança internada com PAC mantém febre alta após 72h de antibiótico adequado. Qual a principal complicação a ser investigada e o melhor exame inicial?

- A) Tuberculose — PPD
- B) Derrame parapneumônico/empiema — ultrassonografia de tórax
- C) Embolia pulmonar — angio-TC
- D) Asma — espirometria
- E) Cardiopatia — ecocardiograma

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

PAC leve em criança >2 meses, vacinada, sem hipoxemia, sem desconforto e aceitando líquidos: tratamento AMBULATORIAL com amoxicilina VO (50-90 mg/kg/dia), foco em pneumococo, com reavaliação em 48-72h. Internação e antibiótico IV não se justificam nesse quadro leve.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Entre 4 meses e 5 anos, os VÍRUS (VSR, influenza, adenovírus, rinovírus) são a causa mais comum de pneumonia. Entre as bactérias, o *S. pneumoniae* lidera. Por isso, em quadro típico bacteriano, a amoxicilina (anti-pneumococo) é a primeira escolha ambulatorial.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Quadro arrastado em escolar, com dissociação clínico-radiológica (RX pior que a ausculta) e sintomas inespecíficos, sugere pneumonia atípica por *Mycoplasma pneumoniae*. O tratamento de escolha é um macrolídeo (azitromicina ou claritromicina).

QUESTÃO 4 → Resposta: C

A hipoxemia ($SpO_2 < 92\%$ em ar ambiente) é o critério objetivo mais importante de gravidade e principal indicação de internação e oxigenoterapia. Febre, leucitose e padrão radiológico isolados não definem a necessidade de internação.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Febre persistente após 48-72h de antibiótico adequado deve levantar suspeita de derrame parapneumônico/empiema. A ultrassonografia de tórax é o melhor exame inicial para detectar, quantificar e guiar a punção/drenagem do derrame.

SM24
Suporte ao Plantão Médico